

CAPÍTULO 14.18

Fenómeno de Raynaud

El **Fenómeno de Raynaud** es un trastorno vascular caracterizado por episodios transitorios de isquemia digital en respuesta al frío o al estrés emocional. La pregunta fundamental que debe hacerse el clínico ante un paciente con esta sintomatología es si se trata de un **Fenómeno de Raynaud Primario** (Enfermedad de Raynaud) o un **Fenómeno de Raynaud Secundario** (Síndrome de Raynaud), este último habitualmente asociado a enfermedades del tejido conectivo.

Clínica y Fases del Fenómeno de Raynaud

La presentación clínica es muy característica y suele afectar uno o más dedos, principalmente de las manos. Se manifiesta a través de cambios de coloración cutánea que siguen una secuencia clásica (aunque no siempre están presentes las tres fases):

TABLA 14.18.1: FASE VS COLOR			
FASE	COLOR	FISIOPATOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
1. Isquémica	Blanco	Vasoconstricción arterial intensa	El dedo pierde el flujo sanguíneo, viéndose pálido.
2. Cianótica	Azul/Morado	Hipoxia tisular	La falta de oxígeno genera una coloración violácea.
3. Hiperémica	Rojo	Reperusión	Al restablecerse la irrigación, el flujo aumenta súbitamente.

NOTA CLÍNICA

En casos severos, especialmente en el Raynaud secundario, la intensidad del vasoespasmo puede ser tal que genere daño isquémico irreversible, manifestándose como **úlceras digitales** o necrosis en la punta de los dedos.

Clasificación: Primario vs. Secundario

La distinción entre ambas formas es el paso más importante en el manejo, ya que el pronóstico y el estudio difieren radicalmente.

Fenómeno de Raynaud Primario

Es una condición benigna, idiopática, que no se asocia a una enfermedad subyacente. Se diagnostica por exclusión cumpliendo los siguientes criterios: - Inicio en edades jóvenes (típicamente entre los **15 y 30 años**). - Episodios simétricos. - Ausencia de síntomas de enfermedad del tejido conectivo. - **Anticuerpos Antinucleares (ANA) negativos**. - Ausencia de daño tisular (no hay úlceras ni necrosis).

Fenómeno de Raynaud Secundario

Se asocia a patologías de base, principalmente autoinmunes. Debe sospecharse si: - El inicio es a edades muy tempranas o después de los 30-40 años. - Los episodios son asimétricos o muy intensos. - Existen signos de daño isquémico (cicatrices puntiformes o úlceras). - Se acompaña de síntomas sugerentes de: - **Esclerosis Sistémica** (Scleroderma): Es la asociación más frecuente y grave. - **Lupus Eritematoso Sistémico**. - Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Todo paciente con fenómeno de Raynaud requiere, al menos una vez, un estudio de **ANA (Anticuerpos Antinucleares)** para descartar una causa autoinmune subyacente.

Diagnóstico y Evaluación

El diagnóstico es eminentemente clínico basado en el relato del paciente y la observación de los cambios de color. Sin embargo, para la clasificación es vital:

- **Anamnesis dirigida:** Buscar síntomas de enfermedades autoinmunes (artralgias, fotosensibilidad, disfagia, engrosamiento de la piel).
- **Examen físico:** Evaluar las puntas de los dedos en busca de isquemia crítica y examinar la piel (esclerodactilia).
- **Laboratorio:** Solicitar **ANA**. Un resultado positivo obliga a profundizar el estudio y sospechar una causa secundaria.
- **Educación:** Es fundamental instruir al paciente sobre los síntomas de alarma de las conectivopatías para que consulte precozmente si estos aparecen.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento depende de la severidad y de si existe una causa identificable.

1. Medidas Generales (No farmacológicas)

Son el pilar del tratamiento, especialmente en el Raynaud primario: - **Evitar el frío:** Es el desencadenante principal. - **Protección térmica:** Uso de guantes, calcetines gruesos y evitar salir en climas gélidos. - **Lavar con agua templada/caliente:** Para revertir el vasoespasmo. - **Evitar el tabaco:** El tabaquismo empeora la vasoconstricción periférica.

2. Tratamiento Farmacológico

Se reserva para casos intensos que no responden a medidas generales o en casos secundarios con riesgo de daño tisular. - **Calcioantagonistas:** El fármaco de elección es el **Amlodipino** (o Nifedipino). Su mecanismo de acción es la vasodilatación periférica, lo que previene la vasoconstricción excesiva y mejora la perfusión.

3. Manejo de la Causa Secundaria

Si el fenómeno es secundario, el tratamiento más importante es el de la **enfermedad de base** (por ejemplo, el manejo específico de la **Esclerosis Sistémica**), además de las medidas sintomáticas mencionadas.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta Raynaud de inicio tardío y tiene úlceras en la punta de los dedos, no asuma que es primario. Es una señal de alarma de isquemia severa y requiere derivación para estudio de conectivopatía.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 22 años con episodios de palidez y cianosis digital al exponerse al frío, sin otros síntomas. ANA negativos. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Fenómeno de Raynaud. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Fenómeno de Raynaud: dedos blancos (isquemia) → morados (cianosis) → rojos (reperusión)
- Siempre diferenciar entre primario y secundario a enfermedad del tejido conectivo
- Primario: sin síntomas de conectivopatía, inicio entre 15-30 años y ANA negativos
- Pedir ANA a todo paciente con fenómeno de Raynaud
- Tratamiento primario: educación (evitar frío) + amlodipino si es intenso
- Si es secundario, tratar la enfermedad de base (esclerodermia, lupus, EMTC)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FENÓMENO DE RAYNAUD)**PREGUNTA 1**

Paciente de 22 años con episodios de palidez y cianosis digital al exponerse al frío, sin otros síntomas. ANA negativos. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Iniciar corticoides
- B)** Solicitar biopsia de piel
- C)** Educar sobre evitar exposición al frío y control
- D)** Iniciar ciclofosfamida
- E)** Solicitar angiografía digital

PREGUNTA 2

¿Qué examen debe solicitarse siempre en un paciente con fenómeno de Raynaud para descartar causa secundaria?

- A)** Factor reumatoide
- B)** ANCA
- C)** ANA
- D)** Anti-CCP
- E)** Complemento C3 y C4

PREGUNTA 3

Paciente de 55 años con fenómeno de Raynaud intenso de inicio reciente. ¿Qué característica hace sospechar causa secundaria?

- A)** Afectación bilateral
- B)** Inicio en edad tardía (fuera del rango 15-30 años)
- C)** Presentación en dedos de las manos
- D)** Cambio de color tricolor
- E)** Mejoría con amlodipino

RESUMEN: FENÓMENO DE RAYNAUD

La clase aborda el fenómeno de Raynaud y la importancia de diferenciar entre primario y secundario (asociado a enfermedades del tejido conectivo). La clínica es característica: uno o más dedos de las manos se ponen blancos (isquemia por vasoconstricción), luego cianóticos (falta de oxígeno) y finalmente rojos (restablecimiento de la irrigación). En casos intensos puede generar daño isquémico en las puntas de los dedos. El manejo del fenómeno de Raynaud primario es educativo (evitar contacto con frío, usar guantes, lavar con agua caliente) y si es intenso se usa amlodipino. Si es secundario, además hay que tratar la enfermedad de base. Para considerar que es primario se requiere: ausencia de síntomas de enfermedad del tejido conectivo, inicio en edad joven (15-30 años) y ANA negativos. Si inicia antes o después de esa edad, o si los ANA son positivos, hay que sospechar causa secundaria.